

복통 감별진단: 맹장염을 놓치지 않기

초기 맹장염(급성충수염)은 처음부터 오른쪽 아랫배가 딱 아프지 않을 수 있습니다. 명치 불편감, 배꼽 주변 통증, 체한 느낌으로 시작해 시간이 지나며 우측 하복부 통증으로 바뀌는 경우가 있습니다.

우측 하복부 통증과 반발 압통을 확인하세요



오늘 바로 확인해야 하는 신호

우측 하복부 통증이나 반발 압통이 생기면

성인에서는 응급실에서 진찰과 복부 CT 등 영상검사 여부를 확인하는 것이 안전합니다. 소아는 초음파 후 필요 시 CT/MRI로 이어질 수 있습니다.

오른쪽 아랫배 통증

걸거나 기침할 때 더 아프고, 특정 부위를 누르면 뚜렷하게 아픕니다.

반발 압통

2-3초 눌렀다가 손을 뗄 때 통증이 더 심해지면 의심 신호입니다.

통증 지속·악화

장염약·복통약을 먹어도 좋아지지 않고 통증이 계속됩니다.

동반 증상

식욕저하, 구역, 발열, 무기력감이 함께 생길 수 있습니다.

응급실 영상검사 고려

우측 하복부 통증, 반발 압통, 배가 단단해짐, 걷기 어려운 통증이 있으면 맹장염·복막 자극 여부를 빠르게 확인해야 합니다.

맹장염 통증은 이렇게 시작될 수 있습니다

1

명치·배꼽 주변 불편감

초기에는 위염·체기처럼 애매한 상복부 불편감으로 느껴질 수 있습니다.

2

구역·식욕저하

설사가 뚜렷하지 않아도 속이 메스껍고 식욕이 떨어질 수 있습니다.

3

우측 하복부로 이동

진행하면 오른쪽 아랫배 압통, 움직임·기침 시 통증이 뚜렷해집니다.

4

복막 자극 신호

반발 압통, 배가 단단해짐, 통증 악화는 응급 평가가 필요합니다.

오른쪽 아랫배가 아니어도 의심해야 하는 경우

고령·소아

통증·열·압통이 약하거나 위치 설명이 어려워 장염처럼 보일 수 있습니다.

약 복용 후 지속

일반 장염약·복통약 후에도 통증이 계속되면 같은 날 재평가가 필요합니다.

다른 복통 원인

장염·위염, 요로결석, 담낭 질환, 여성 골반통도 감별이 필요합니다.

